

Здоровый новорождённый

Первый час · скрининги · профилактика · критерии выписки

1. КТО СЧИТАЕТСЯ ЗДОРОВЫМ

Здоровый новорождённый — доношенный ребёнок, родившийся в удовлетворительном состоянии, у которого нет заболеваний и патологических состояний. Диагноз ставится, если выполнено **всё**:

- Спонтанное дыхание в течение **30 секунд** после рождения и ЧСС **более 100 в минуту**.
- По физикальным данным — без видимых пороков развития.
- Нет нарушений по данным клинического, лабораторного и инструментального обследования.
- Не потребовалась дополнительная медицинская помощь, связанная с изменением состояния в родильном доме.
- За время наблюдения в роддоме не выставлен другой диагноз.

Масса тела	2300-4100 г	Длина тела	45-53 см
Окружность головы	31-36 см	Частота дыхания	30-60 в минуту
ЧСС в покое	110-160 в минуту	Оценка	По центильным таблицам международных стандартов роста

2. ТАЙМЛАЙН

Когда	Что делаем
Первые секунды	Оценить состояние и потребность в реанимации. Если реанимация не нужна — выложить на живот или грудь матери, контакт «кожа к коже» при неотсечённой пуповине
60-120 секунд	Отсроченное пережатие и пересечение пуповины , если нет необходимости в немедленной помощи матери или ребёнку
1-я и 5-я минуты	Оценка по шкале Апгар: дыхание, сердцебиение, цвет кожи, рефлексы, мышечный тонус
Первый час	Первое прикладывание к груди — независимо от способа родоразрешения. Большинство детей готовы к кормлению уже через 15 минут
После прикладывания	И только после него: взвешивание, измерение окружностей и длины тела, обработка культи пуповины. Профилактика инфекции глаз, витамин К
Первые 24 часа	Вакцинация против гепатита В
Не позже 2 часов	Повторный осмотр дежурным врачом-неонатологом — в родзале перед переводом или уже в отделении
Первые сутки	Осмотр медсестрой каждые 3-3,5 часа
24-48 часов	Забор крови на неонатальный скрининг (у доношенного)
36-48 часов	Скрининг на критические ВПС
3-и сутки	Вакцинация БЦЖ (при ранней выписке — с третьих суток)
3-4-е сутки	Аудиологический скрининг — вызванная отоакустическая эмиссия
Ежедневно	Осмотр не реже 1 раза в день; при ухудшении — не реже 1 раза в 6 часов

Санация верхних дыхательных путей, зондирование желудка и оценка проходимости прямой кишки зондом проводятся **только по показаниям**. Глубокая и агрессивная фарингеальная стимуляция может вызвать аритмию, ларингоспазм, бронхоспазм и апноэ.

3. СКРИНИНГ НА КРИТИЧЕСКИЕ ВПС — 36-48 ЧАСОВ

Условия проведения
Ребёнок должен быть **сыт и согрет**, в состоянии спокойного бодрствования или сна. Измерения пре- и постдуктально (правая рука и любая нога) при одном мониторе — с промежутком **не более 1-2 минут**. Если во время измерения состояние сменилось (сон ↔ бодрствование ↔ плач) — повторить через 5 минут после достижения покоя.

Что оцениваем	Первичный скрининг пройден, если
Цвет кожи и слизистых	Розовые
Периферическая пульсация	Удовлетворительная, симметричная на правой плечевой и бедренных артериях
Пульсоксиметрия	Пре- и постдуктально 95% и более
Разница SpO ₂	Менее 3% между пре- и постдуктальным значением

Расширенный скрининг	Как
Когда	Если первичный скрининг не пройден
Что делать	Трёхкратное ежечасное пре- и постдуктальное измерение пульсоксиметрии и систолического АД, оценка периферической пульсации, цвета кожи и слизистых, темпов диуреза
Пройден, если	Пульсация удовлетворительная и симметричная; кожа и слизистые розовые; диурез адекватный; SpO ₂ пре- и постдуктально ≥ 95% с разницей менее 3% в динамике; разница САД пре- и постдуктально 10 мм рт. ст. и менее
Не пройден	Назначается эхокардиография для исключения критического ВПС

Манжеты для измерения АД — одноразовые детские (3,3-5,6; 4,2-7,1; 5,4-9,1; 6,9-11,7 см). Манжета должна покрывать не менее двух третей длины плеча или бедра и охватывать всю окружность конечности. При «пройденном» скрининге в истории болезни делается пометка «скрининг на критические ВПС пройден».

4. СКРИНИНГИ: НЕОНАТАЛЬНЫЙ И СЛУХОВОЙ

Скрининг	Когда и как
Неонатальный и расширенный неонатальный	Кровь из пятки через 3 часа после кормления : у доношенного в 24-48 часов , у недоношенного на 7-е сутки (144-168 часов) . Два фильтровальных тест-бланка от медико-генетической консультации; результат — в срок до 10 дней. Фиксируется в истории развития и в выписном эпикризе
Аудиологический	Всем в роддоме в 3-4 дня — вызванная отоакустическая эмиссия. Дети из группы риска по тугоухости и те, кто отнесён к ней по результату, направляются в сурдологический центр до 3 месяцев для ВОАЭ и КСВП
Группа крови, Кумбс, билирубин	Селективно, по клиническим показаниям. В родблоке при показаниях — экспресс-метод цоликлонами с записью на титульном листе. Полную лабораторную панель проводят только детям с риском ГБН
Общий анализ крови	Селективно, по показаниям
НСГ, ЭхоКГ, УЗИ живота, почек, тазобедренных суставов	Селективно, по показаниям и с учётом возможностей учреждения

В день БЦЖ — никаких других парентеральных манипуляций
В день вакцинации против туберкулёза ребёнку **не проводят никаких других парентеральных вмешательств, включая неонатальный скрининг**. Планируйте забор крови и вакцинацию на разные дни.

5. ПРОФИЛАКТИКА В РОДДОМЕ

Что	Как	Детали
Инфекции глаз	Эритромициновая глазная мазь	После протирания каждого века — полоса 0,5-1 см в каждый нижний конъюнктивальный мешок, лёгкий массаж век; избыток стереть через минуту
Витамин К	Фитоменадион 1 мг внутримышечно в первые часы	Недоношенным менее 36 недель с массой ≥ 2500 г — 1 мг в/м или в/в; при массе < 2500 г — 0,4 мг/кг . Действует через 30 минут. Нужно письменное согласие матери
	Если фитоменадиона нет — менадиона натрия бисульфит 1%	1-1,5 мг/кг/сут (0,1-0,15 мл/кг/сут) в/м, но не более 4 мг/сут, 1-3 раза в сутки. Действие начнётся только через 8-24 часа
Гепатит В	Первая доза всем в первые 24 часа	Схема 0-1-6 месяцев. У детей от матерей-носителей и больных — 0-1-2-12 месяцев
Туберкулёз	БЦЖ строго внутрикожно на границе верхней и средней трети наружной поверхности левого плеча	Должна образоваться беловатая папула 7-9 мм , исчезающая через 15-20 минут. Введение под кожу недопустимо — холодный абсцесс. Реакция развивается через 4-6 недель, обрабатывать её ничем нельзя

Активно-пассивная иммунизация (вакцина + иммуноглобулин человека против гепатита В) показана детям от матерей с острым вирусным гепатитом В, ранних реконвалесцентов и носительниц HBsAg. Вакцина вводится **через 2 часа после иммуноглобулина**.

6. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Противопоказания со стороны матери	Со стороны ребёнка
Онкологические заболевания, требующие химиотерапии	Галактоземия
Открытая форма туберкулёза с бацилловыделением	Фенилкетонурия
Особо опасные инфекции — натуральная оспа, сибирская язва	Болезнь кленового сиропа (валинолейцинурия)
ВИЧ-инфекция матери	
Психические заболевания в стадии обострения	
Острый гепатит В и С в активной фазе	
Препараты, несовместимые с грудным вскармливанием	

- Грудной имплантат **не** противопоказание. Размер и форма груди и соска на функцию молочной железы не влияют.
- При HBsAg у матери грудное вскармливание возможно **после** активно-пассивной иммунизации ребёнка.
- При гриппе, ветряной оспе, COVID-19 вскармливание можно продолжить при дистанцировании и соблюдении гигиены, либо кормить сцеженным молоком.
- Если мать получает противопоказанный препарат — искать аналог, совместимый с грудным вскармливанием.
- Длительность сосания у здоровых доношенных **не ограничивают**. Для полноценной лактации нужно совместное пребывание матери и ребёнка.

7. УХОД И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Что	Как
Температура в родзале	Не менее 25 °С, без сквозняков; включить источник лучистого тепла, согреть лоток и пелёнки. Гипотермия начинается при температуре тела 36 °С и ниже
Пуповинный остаток	Сухое ведение. Стерильные условия не нужны. Не обрабатывать антисептиками — ни этанолом, ни перманганатом калия, ни метилтиониния хлоридом. При загрязнении — промыть водой и осушить. Отпадает на 1-2-й неделе
Кожа	Купать в тёплой водопроводной воде без антисептиков и настоев трав. Шампуни и пены — не чаще 1-2 раз в неделю. Средства для ухода — на водной основе
Подгузники	Менять при наполнении и сразу после дефекации, в течение дня устраивать воздушные ванны

8. КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ

Критерий	Норма
Кормление	Активно сосёт из груди и/или из бутылочки через соску
Усвоение питания	Питание усваивается
Температура тела	Нормальная
Убыль массы тела	Менее 10% от массы при рождении
Обследования	По выполненным по показаниям исследованиям нет патологических изменений либо отклонения незначительные, не угрожающие жизни и здоровью и не требующие стационарного наблюдения и лечения

При выписке медицинская организация оформляет документацию и передаёт информацию о выписке в поликлинику по месту фактического проживания для организации патронажа на дому. Результаты аудиологического скрининга и забора крови на неонатальный скрининг вносятся в выписную справку; если отметки нет — исследование проводится в детской поликлинике.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Здоровый новорожденный, рожденный в условиях стационара» — ID 924_1, размещены 08.07.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/924_1
- Критерии диагноза, нормативы осмотра, сроки и порядок скринингов, дозы профилактических препаратов, правила ухода и критерии выписки приведены по разделам 2, 3, 5 и 6 КР «Здоровый новорожденный, рожденный в условиях стационара» и приложению Б тех же КР.